

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

CONSENSO INFORMATO PER AGOASPIRATO, BIOPSIA E REPERE CON GUIDA STRUMENTALE

Modulo di consenso informato per agoaspirato, biopsia
e posizionamento repere con guida strumentale

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MOD155_00	00	27/04/2026	3
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	Direzione Generale	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Rosetta Greco	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
27/04/2026	27/04/2026	27/04/2026

Toscana Diagnostica S.r.l.

Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

Dati del paziente

Cognome e Nome	
Data di nascita	
Codice Fiscale	
In qualità di (paziente/genitore/tutore)	
Medico informante	
Data procedura	

1. Sintesi informativa

Si tratta di una procedura indispensabile per una precisa definizione di natura (benigna/maligna) della lesione mammaria identificata con ecografia, mammografia o risonanza magnetica. La procedura di ago-aspirato/biopsia prevede, sotto guida ecografica, mammografica (mammostereotassica) o RM, il posizionamento di un ago nella lesione per effettuare un prelievo di cellule o tessuto. Il materiale prelevato viene trasferito, con le dovute modalità, presso il Laboratorio esterno.

2. Tipologie di procedura

Agoaspirato (esame citologico): si esegue con un ago sottile, lo stesso utilizzato per iniezioni intramuscolo, senza anestesia. È prevista l'esecuzione di prelievi multipli nella stessa lesione.

Agobiopsia (esame istologico): rispetto all'agoaspirato, l'ago utilizzato è di maggior calibro e si pratica l'anestesia locale. Generalmente vengono effettuati multipli prelievi nella stessa lesione (4-5 nelle procedure a guida ecografica, 12-18 in quella sotto guida mammografica, stereotassica o RM).

Repere: nella lesione, quando non palpabile, viene posizionato un repere utile al chirurgo per localizzarla. Si possono utilizzare in alternativa una iniezione di soluzione con carbone, un sottile filo metallico o un liquido radioattivo (ROLL).

3. Eventuali complicanze

L'esame può essere fastidioso, raramente doloroso. Nelle procedure eseguite con guida mammografica o RM è necessario rimanere immobili più a lungo (generalmente in posizione prona). Sono evenienze rare le emorragie, mentre gli ematomi sono conseguenza frequente, peraltro generalmente di modesta entità e a risoluzione spontanea in pochi giorni; più rare le infezioni della ghiandola mammaria (mastiti). Esiste il rischio molto remoto di puntura accidentale del cavo pleurico con conseguente pneumotorace o di bucare le protesi.

4. Preparazione e raccomandazioni

Non è necessaria alcuna preparazione. Per ridurre il rischio di sanguinamento in caso di agobiopsia, specie con sistema VAB, occorre, sentito il proprio medico curante, sospendere l'assunzione di farmaci anticoagulanti o a base di acido acetilsalilico (aspirinetta) nelle 48 ore precedenti la biopsia. Non è invece necessario interrompere altre eventuali terapie farmacologiche in corso.

5. Espressione del consenso

Preso visione delle informazioni relative alla procedura in oggetto, valutate le informazioni ricevute e i chiarimenti che mi sono stati forniti:

Scelta	Barrare
Accetto di sottopormi all'indagine proposta	☐
Rifiuto di sottopormi all'indagine proposta	☐

Ruolo	Firma	Data
Paziente (o genitore/tutore)		
Medico Radiologo		